PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

Morte súbita no esporte

Frequência, causas e o que muda o desfecho

Medicina Esportiva Clínica

DEPOIS DE TODO CASO

Duas frases erradas, em direções opostas

“Foi azar, não dava para fazer nada.”

leva ao conformismo

“Com certeza não fizeram os exames direito.”

leva à ilusão de que exigir exame basta

1 2 3 4 5

cinco erros

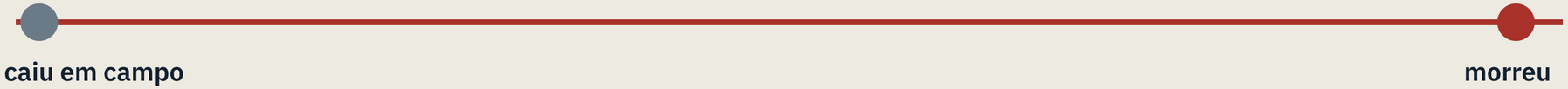
o quinto é o que mais mata

DOIS COLAPSOS EM CAMPO

A diferença esteve nos minutos seguintes

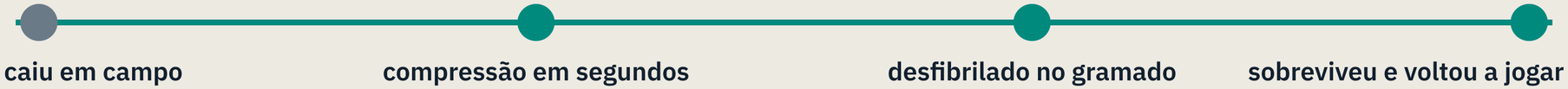
2004, Brasil

profissional, avaliado e acompanhado



2021, Eurocopa

profissional, avaliado e acompanhado



a linha começa na queda; sem escala de minutos

> A diferença entre os desfechos não foi o exame de admissão.

ERRO UM: A FREQUÊNCIA

Raro, e concentrado



6,8

por 100 mil adolescentes do futebol inglês, no seguimento depois do rastreio

Raro não é improvável numa vida institucional. Evento raro, fatal e com resposta conhecida é exatamente o evento para o qual se prepara.

Harmon, Circulation 2015 · Malhotra, NEJM 2018

ERRO DOIS: A CAUSA

Dois bons estudos, dois quadros

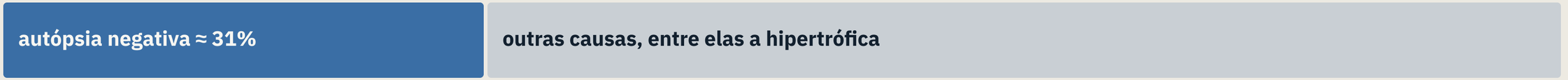
O registro de Maron, 2009

1.866 mortes, 1980 a 2006; montado em boa parte a partir de notícias



As autópsias revisadas, 2014

cada caso julgado por painel; a hipertrófica apareceu pouco



> Parte relevante das mortes é doença elétrica. Isso valoriza o eletrocardiograma, limita a imagem e explica por que nenhum exame zera o risco.

Não só o jovem de elite



ERRO QUATRO: O QUE O RASTREIO FAZ

Rastreio não é vacina

11.168
adolescentes com eletro e eco

42
com doença associada a morte súbita (0,38%)
o rastreio funcionou

no seguimento: 8 mortes cardíacas
6 de 8 tinham rastreio normal



Reduz, não elimina. Fotografa um momento, e doença genética se expressa com o tempo.

Malhotra e colaboradores · New England Journal of Medicine 2018

Três consequências

O rastreio reduz, não elimina

Rastreio exige seguimento

exame de entrada arquivado numa pasta é quase decorativo

Sintoma novo vale mais que exame antigo

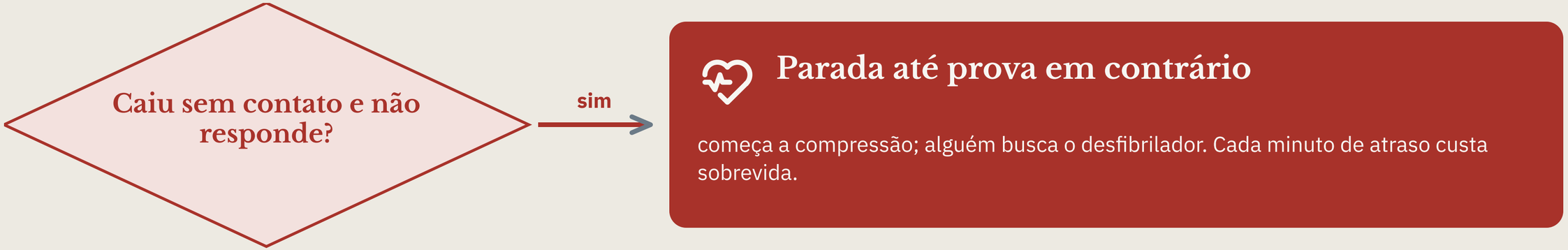
“mas ele fez todos os exames” é a frase mais perigosa

A preparação para o evento não é opcional

não é pessimismo; é a conclusão lógica do dado

ERRO CINCO: O DA HORA

Caiu sem contato e não responde: é parada



Não excluem a parada:

- abalos que parecem convulsão
- respiração agônica, o gasping
- “está respirando, então não é parada”

> Cada minuto de atraso custa sobrevida. Todo o departamento precisa saber a regra de cor.

O NÚMERO QUE NENHUM EXAME ALCANÇA

89% de sobrevida com o desfibrilador do local usado

89%

de sobrevida com o desfibrilador do local usado

Reconhecer rápido

caiu sem contato e não responde

Comprimir cedo

quem estiver mais perto

Desfibrilar cedo

aparelho acessível, em minutos

> A pergunta certa para clube, escola e prova: “o que vocês fazem quando alguém cai?”. Se é difícil nos clubes profissionais de São Paulo, imagine na várzea.

Registro americano de ensino médio, BJSM 2013 · Revista Brasileira de Medicina do Esporte 2011

O que as substitui

~~“É raríssimo.”~~	raro, concentrado, e com resposta conhecida: prepare-se
~~“É sempre hipertrófica.”~~	parte relevante é doença elétrica em coração normal
~~“É coisa de jovem de elite.”~~	acima dos 35 é coronária; o amador é o menos coberto
~~“Com exame não teria acontecido.”~~	6 de 8 tinham rastreio normal; seguimento e sintoma
~~“Deve ser convulsão.”~~	caiu e não responde: compressão e desfibrilador

A PARTE QUE MAIS MUDA O DESFECHO NÃO É MÉDICA

Os minutos seguintes à queda

- Rastreio reduz, não elimina; exige seguimento
- Sintoma novo passa por cima de exame antigo
- Caiu sem contato e não responde: compressão e desfibrilador

Médico

Pede, interpreta, decide elegibilidade.

Quem estiver mais perto

Reconhece e começa a compressão. Nenhuma profissão é dona dela.

A gestão

Desfibrilador acessível, plano escrito, ensaio periódico.

Levar sintoma a sério é de todo mundo.